CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · PEDIATRIC NURSING DEPT

Assessment of *Growth & Development*

Importance of Growth & Developmental Screening, Cross-Sectional vs. Longitudinal Methods, Physical Growth Percentile Charts, Developmental Assessment Measures (Table 14-2), Testing Considerations, and the Denver II (DDST) Screening Tool (125 Tasks, 4 Domains, Scoring & Referral).

Lecture Summary · **Pediatric Nursing Department** · *Cairo University*

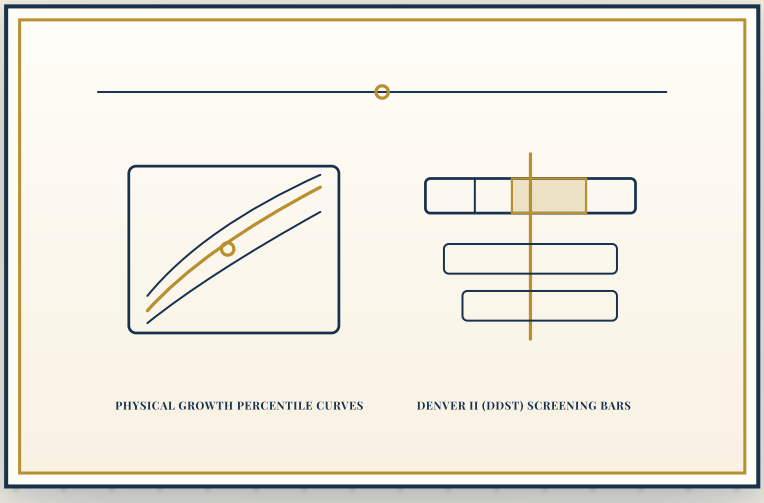


PLATE I — *Serial growth curve plotting across age percentiles (left) and Denver II milestone bars intersected by the child's age line (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

بالكامل طبقًا لـ **إرشاد للمذاكرة: تقييم النمو والتطور (Assessment of Growth and Development)** — يغطي هذا الملخص محاضرة وكتاب قسم تمريض الأطفال بجامعة القاهرة للنص الرسمي حرفيًا مع أسئلة التقييم الذاتي الرسمية بالكلية.

1. Introduction, Importance, Assessment Methods & Physical Growth

1. Introduction & Importance of G&D Assessment

— **Introduction:**

- One of the most essential components of a **complete health appraisal** is assessment of growth and developmental function.
- Developmental and growth assessment can be administered in a variety of **settings: home, school, daycare center, hospital, or clinic**.
- **Nurses** can play a vital role in providing this service.

— **Importance of G&D Assessment (Screening Procedures are Designed to):**

- **1.** Identify quickly and reliably children whose developmental level is **below normal** for their age and who therefore require further investigation.
- **2.** Validation that a child is developing **normally**.
- **3. Early** detection of problems: developmental assessment may reassure parents or detect problems in early infancy.
- **4.** Provide a means of recording objective measurements of present developmental function **for future reference**. Testing in late childhood can help detect academic and social problems early enough to minimize possible negative consequences.
- **5.** Identification of **concerns of caregivers** and child.
- **6.** Provision of an opportunity for **anticipatory guidance and teaching** about age-appropriate expected behaviors.

مقدمة وأهمية تقييم النمو والتطور (Importance of G&D Assessment):
• **مقدمة:** يُعد تقييم وظائف النمو والتطور أحد أهم المكونات الأساسية **للتقييم الصحي الشامل (Complete health appraisal)**، ويمكن إجراؤه في أماكن متنوعة: **المنزل، المدرسة، الحضانة (Daycare center)، المستشفى، أو العيادة**، وتلعب **الممرضات** دورًا حيويًا في تقديم هذه الخدمة.
• **أهمية إجراءات الفحص والتقييم:** (1) التعرف السريع والموثوق على الأطفال الذين يكون مستوى تطورهم **أقل من الطبيعي** لأعمارهم ويحتاجون لفحوصات إضافية، (2) التأكد من أن الطفل ينمو ويتطور **بشكل طبيعي**، (3) **الاكتشاف المبكر للمشاكل** في الطفولة المبكرة أو طمأنة الوالدين، (4) تسجيل قياسات موضوعية للوظيفة التطورية الحالية **كمرجع مستقبلي** (والفحص في الطفولة المتأخرة يكتشف المشاكل الدراسية والاجتماعية مبكرًا)، (5) تحديد **مخاوف مقدمي الرعاية** والطفل، (6) توفير فرصة **للإرشاد الاستباقي (Anticipatory guidance) والتعليم** حول السلوكيات المتوقعة المناسبة للعمر.

2. Methods of Assessing G&D & Physical Growth Parameters

METHODS OF ASSESSING G&D

— **1. Cross-sectional method:** The child can be compared with a **representative group of children at the same point in time**.

— **2. Longitudinal method:** The **same child** can be measured & compared at **different points in time**.

— **Common Parameters: Height, weight, & motor skills** are the most common parameters used for the average age.

PHYSICAL GROWTH PARAMETERS

— The parameters of **weight, length, or height, and head circumference** (dependent on age) are essential in serial physical growth measurements.

— **Note:** *Chest circumference is of less importance.*

— By **plotting a child's growth on a chart**, the nurse is able to determine normal or abnormal growth curves according to the child's age.

BOYS AND GIRLS: BIRTH TO 24 MONTHS (4 CHARTS)	BOYS AND GIRLS: 2 TO 20 YEARS (4 CHARTS)
1) **Weight for age percentiles**	1) **Weight for age percentiles**
2) **Length for age percentiles**	2) **Stature-for-age percentiles**
3) **Head circumference for age**	3) **Body mass index–for-age percentiles (BMI-for-age)**
4) **Weight for length percentiles**	4) **Weight-for-stature percentiles**

طرق تقييم النمو والتطور ومنحنيات النمو الجسدي (Physical Growth Charts):
• **طرق التقييم:** (1) **الطريقة المقطعية العرضية (Cross-sectional):** مقارنة الطفل بمجموعة ممثلة من الأطفال **في نفس النقطة الزمنية.** (2) **الطريقة الطولية (Longitudinal):** قياس ومقارنة **نفس الطفل في نقاط زمنية مختلفة.** (الطول والوزن والمهارات الحركية هي أكثر المقاييس استخدامًا).
• **مقاييس النمو الجسدي: الوزن، الطول (Length مستلقيًا أو Height/Stature واقفًا)، ومحيط الرأس** حسب العمر هي المقاييس الأساسية في القياسات المتسلسلة (بينما **محيط الصدر أقل أهمية**).
• **منحنيات النمو (Growth Charts):** من **الولادة حتى 24 شهرًا** (الوزن للعمر، الطول مستلقيًا للعمر، محيط الرأس للعمر، والوزن للطول)؛ ومن **2 إلى 20 سنة** (الوزن للعمر، القامة للعمر، مؤشر كتلة الجسم BMI للعمر، والوزن للقامة).

2. Developmental Assessment & Examples of Assessment Measures

1. Concept & Evaluated Aspects of Developmental Assessment

— **Definition: Developmental assessment** is the process of **mapping a child's performance compared with children of similar age**.

— **Preparation & Training:** Some developmental assessment instruments can be administered in a variety of settings with a **minimal level of preparation**, whereas others require **proper training and supervision**.

— **These Tests Evaluate a Variety of Aspects Including (5 Core Aspects):**

- **1. Fine and gross motor skills**
- **2. Social and language skills**
- **3. Behavior, temperament**
- **4. Cognition, memory**
- **5. Child's home environment**

مفهوم تقييم التطور والجوانب التي تقيسها اختبارات التطور:
• **التعريف:** عملية تخطيط ومقارنة أداء الطفل بأداء الأطفال **من نفس العمر (Similar age)**؛ وبعض الأدوات تُجرى بتحضير بسيط، بينما يتطلب بعضها الآخر **تدريبًا وإشرافًا مناسبين.**
• **الجوانب الخمسة التي تقيمها هذه الاختبارات:** (1) المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة، (2) المهارات الاجتماعية واللغوية، (3) السلوك والمزاج (Temperament)، (4) الإدراك والذاكرة، (5) البيئة المنزلية للطفل.

2. Examples of Developmental Assessment Measures for Infants and Children (Table 14-2)

TEST NAME	AGES	FEATURES EVALUATED
Carey–Revised Infant	**4 to 8 months**	Temperament, patterns of feeding, sleeping, elimination, responses to different situations.
Denver Articulation Screening Exam (DASE)	**2.5 to 6 years**	Intelligibility; articulation of **30 sound elements**.
Denver II	**Birth to 6 years**	**Personal-social, fine motor-adaptive, language, gross motor**.
Developmental Profile II	**Birth to 9 years**	Physical, self-help, social, academic, communication skills.
Early Language	**Birth to 3 years**	Auditory expressive and receptive, visual components of speech.
Goodenough–Harris Drawing Test	**5 to 17 years**	Child's drawing of a person; analyzed for body parts, clothing, proportion, perspective.
HOME (Home Observation for Measurement of the Environment)	**Birth to 6 years**	Organization, play materials, parental control, stimulation, punishment or restriction.
McCarthy Scales of Children's Abilities	**2.5 to 8.5 years**	Intellectual and motor development, memory, quantitative, perceptual-performance, general cognition.

أمثلة مقاييس تقييم التطور للرضع والأطفال (جدول 14-2 بالمحاضرة):
• **مقياس كاري للرضع (Carey–Revised Infant):** من **4 إلى 8 شهور** (يقيس المزاج وأنماط الرضاعة والنوم والإخراج والاستجابات).
• **اختبار دنفر لفحص النطق (Denver Articulation):** من **2.5 إلى 6 سنوات** (وضوح الكلام ونطق **30 عنصرًا صوتيًا**).
• **اختبار دنفر الثاني (Denver II):** من **الولادة إلى 6 سنوات** (المجالات الأربعة: الشخصي-الاجتماعي، الحركي الدقيق-التكيفي، اللغة، والحركي الكبير).
• **الملف التطوري الثاني (Developmental Profile II):** من **الولادة إلى 9 سنوات** (المهارات الجسدية، رعاية الذات، الاجتماعية، الأكاديمية، والتواصل).

• **اللغة المبكرة (Early Language):** من **الولادة إلى 3 سنوات** (المكونات السمعية التعبيرية والاستقبالية والبصرية للكلام).
• **اختبار جودإينف-هاريس للرسم (Goodenough–Harris Drawing Test):** من **5 إلى 17 سنة** (رسم الطفل لشخص وتحليله لأجزاء الجسم والملابس والتناسب والمنظور).
• **مقياس البيئة المنزلية (HOME):** من **الولادة إلى 6 سنوات** (التنظيم، أدوات اللعب، رقابة الوالدين، التحفيز، والعقاب أو التقييد).
• **مقاييس مكارثي لقدرات الأطفال (McCarthy Scales):** من **2.5 إلى 8.5 سنوات** (التطور العقلي والحركي، الذاكرة، الكمّي، الأداء الإدراكي، والمعرفة العامة).

3. Considerations for Developmental Assessment

Key Clinical & Behavioral Considerations During Testing (10 Principles)

DOMAIN	CONSIDERATION & IMPACT ON ASSESSMENT RESULTS
1. Community & Family Context	Assessing a child within the **context of his or her community** and the interacting social systems, and taking into account the **family's needs, resources, and concerns** affect both the evaluation and possible interventions.
2. Testing Environment	Informal **relaxed settings** where the child can be as much at ease as possible are recommended when doing assessment.
3. High Activity & Short Attention Span	A young child is **very active and has a short attention span**. This can be difficult to deal with in a testing situation.
4. Surrounding Stimuli	The world around young children is so interesting that they are so busy **concentrating on other stimuli**.
5. Engaging Tasks	The task at hand needs to be **very interesting to keep the child busy** and to be an adequate source of stimulation.
6. Task Preference	Because children have a tendency to **favor certain tasks over others**, the test results can be **influenced**.
7. Movement & Accuracy	The child is probably capable of completing a substantial amount of the test, but, because of the **frequent movement and limited concentration**, the test results can **not always be accurate**.
8. Cognitive Stage	The **stage of cognitive development** has an influence on what the child understands.
9. Child's Emotions	The examiner needs to focus more intently on the **emotions of the child**, as they are meaningful and represent how the child is feeling.
10. Social Relationships	Children's **social relationships** can have a considerable effect on their cognitive growth and this in turn influences the assessment situation.

الاعتبارات الهامة عند إجراء تقييم التطور (Considerations for Developmental Assessment):
• **1. سياق المجتمع والأسرة:** تقييم الطفل في سياق مجتمعه والنظم الاجتماعية المتفاعلة، مع مراعاة احتياجات الأسرة ومواردها ومخاوفها.
• **2. بيئة الفحص:** يوصى بإجراء التقييم في **أجواء غير رسمية ومريحة (Informal relaxed settings)** يشعر فيها الطفل بالاطمئنان.
• **3. النشاط الزائد وقصر مدى الانتباه:** الطفل الصغير نشيط جدًا ولديه **مدى انتباه قصير (Short attention span)**، وينشغل بالتركيز على المثيرات الأخرى المحيطة به؛ لذا يجب أن تكون المهمة **شيقة جدًا لإبقاء الطفل منشغلًا** ومصدرًا كافيًا للتحفيز.
• **4. تفضيل المهام ودقة النتائج:** يميل الأطفال لتفضيل مهام معينة على غيرها مما قد يؤثر على النتائج، وبسبب كثرة الحركة ومحدودية التركيز قد **لا تكون نتائج الاختبار دقيقة دائمًا** رغم قدرة الطفل الفعلية على الأداء.
• **5. الإدراك والمشاعر والعلاقات الاجتماعية:** تؤثر مرحلة التطور المعرفي على ما يفهمه الطفل، ويجب على الفاحص التركيز بانتباه على **مشاعر الطفل (Emotions of the child)** لأنها تعبر عما يشعر به، كما تؤثر **العلاقات الاجتماعية للطفل** بشكل كبير على نموه المعرفي وموقف التقييم.

4. Denver II (DDST): History, Purpose & The 4 Developmental Sections

1. Historical Background, Overview & Purpose of Denver II

— **Historical Background:**

- **Denver II (1992)** — Previously the **Denver Developmental Screening Test, DDST (1967)**, and its revision, the **DDSTR**— have been revised, restandardized, and renamed the **Denver II**.
- The most widely used developmental screening tests for **young children**.
- Has been used and standardized in over **12 countries** and used to screen over **50 million children**.

— **Definition & Age Range:** A commonly used tool for assessing **neuromuscular development** of the child from **birth through 6 years of age** to detect developmental delay.

— **Purpose (3 Core Purposes):**

- **1.** Identify young children with **developmental issues**.

- **2.** It was designed to give a **brief overview of the child's development**.
- **3.** To identify those **who are not performing as well as other children of the same age**.

— **Administration & Observation:**

- Denver II can be conducted by **Professionals or para-professionals**.
- The test utilizes both **parent observation and direct observation**.

اختبار دنفر الثاني للفحص التطوري (Denver II / DDST) — الخلفية التاريخية والغرض:
• **الخلفية التاريخية:** صدر **Denver II** عام **1992** كنسخة مراجعة ومُعاد تقنينها لاختبار دنفر الأصلي **DDST (1967)** ومراجعته **DDSTR**؛ وهو أكثر اختبارات الفحص التطوري استخدامًا للأطفال الصغار، حيث تم تقنينه في أكثر من **12 دولة** واستخدم لفحص أكثر من **50 مليون طفل**.
• **التعريف والغرض:** أداة شائعة لتقييم **التطور العصبي العضلي (Neuromuscular development)** للطفل من **الولادة حتى سن 6 سنوات** لاكتشاف التأخر التطوري.
ويهدف إلى: (1) اكتشاف الأطفال الصغار الذين يعانون من مشاكل تطورية، (2) إعطاء نظرة عامة موجزة عن تطور الطفل، (3) تحديد الأطفال الذين لا يؤدون بنفس كفاءة أقرانهم من نفس العمر.
• **من يجريه وكيف يجرى؟** يمكن إجراؤه بواسطة **المتخصصين أو المساعدين شبه المتخصصين (Professionals or para-professionals)**، ويعتمد على كلٍّ من **ملاحظة الوالدين والملاحظة المباشرة (Parent observation and direct observation)**.

2. Composition of Denver II: 125 Tasks Across 4 Developmental Sections

The Denver II screening tool includes **125 tasks (or items) in total**, distributed across **four developmental areas**:

SECTION / DOMAIN	SKILLS ASSESSED & EXAMPLES (SLIDE & DEPARTMENT BOOKLET TEXT)
1. Personal–Social	— **Slide summary:** Getting along with people and caring for personal needs. — **Booklet details:** Assesses how a child interacts with others and their ability to manage personal tasks, like **dressing or feeding themselves**. It also looks at social behaviors such as **making eye contact and responding to others**.
2. Fine Motor–Adaptive	— **Slide summary: Eye-hand coordination, manipulation of small objects, and problem solving**. — **Booklet details:** Focuses on a child's ability to use their hands and fingers. Includes tasks like **drawing, stacking blocks, or picking up small objects**, which are indicators of fine motor skills and hand-eye coordination.
3. Language	— **Slide summary: Hearing, understanding, and using language**. — **Booklet details:** Evaluates the child's ability to understand and produce language. Includes tasks like **responding to questions, using words, or following simple commands**, which show progress in communication skills.
4. Gross Motor	— **Slide summary: Sitting, walking, jumping, and overall large muscle movement**. — **Booklet details:** Assesses the development of larger muscle groups and movement. Looks at abilities like **crawling, walking, running, jumping, and climbing**, which help gauge physical strength and coordination.

Milestone Organization: Each component includes specific milestones typical for certain age ranges, organized by age. Tasks that a child fails to perform are considered to indicate possible developmental delays, which might require further evaluation.

أقسام اختبار دنفر الثاني الأربعة (125 مهمة/بندًا إجمالًا):
• **1. الشخصي–الاجتماعي (Personal–Social):** الانسجام والتفاعل مع الآخرين والعناية بالاحتياجات الشخصية (مثل ارتداء الملابس، إطعام النفس، التواصل البصري، والاستجابة للآخرين).
• **2. الحركي الدقيق–التكيفي (Fine Motor–Adaptive):** التآزر البصري اليدوي، والتعامل مع الأشياء الصغيرة، وحل المشكلات (مثل الرسم، رص المكعبات، والتقاط الأشياء الصغيرة باليدين والأصابع).
• **3. اللغة (Language):** السمع، وفهم اللغة، واستخدامها/إنتاجها (مثل الإجابة عن الأسئلة، استخدام الكلمات، أو اتباع الأوامر البسيطة).
• **4. الحركي الكبير (Gross Motor):** الجلوس، الحبو، المشي، الجري، القفز، التسلق، وحركة العضلات الكبيرة الكلية لقياس القوة البدنية والتناسق.

5. Denver II Scoring, Interpretation & Referral Recommendations

1. Scoring Per Item (4 Item Ratings)

RATING CODE	EXACT SCORING DEFINITION
1) P (Pass)	Child **successfully performs item** or **caregiver reports** the child can do the item.
2) F (Fail)	Child **does not successfully perform the item** and/or the **caregiver reports the child cannot do the item**.
3) NO (No Opportunity)	The child has **not had the opportunity to perform the task due to restrictions**.
4) R (Refusal)	The child **refuses to attempt** and the **parent cannot report**.

2. Interpretation of Denver II Individual Item Scores (4 Classifications)

ITEM RESULT	POSITION RELATIVE TO THE AGE LINE & PERCENTILES
1) Advanced	**Passed** an item completely to the **right of the age line** (passed by **less than 25% of children**).
2) OK (Normal)	**Passed, failed, or refused** an item intersected by the age line between the **25th and 75th percentiles**.
3) Caution	**Failed or refused** items intersected by the age line **on or between the 75th and 90th percentiles**.
4) Delay	**Failed** an item completely to the **left of the age line**; **refusals to the left of the age line** may also be considered delays because the reason for the refusal may be inability to perform the task.

تسجيل درجات البنود (Scoring per Item) وتفسير كل بند في اختبار Denver II:

• **رموز تسجيل البنود الأربعة: P (اجتياز Pass):** يؤدي الطفل المهمة بنجاح أو يبلغ مقدم الرعاية أنه يستطيع أداءها | **F (فشل Fail):** لا ينجح الطفل في الأداء و/أو يبلغ مقدم الرعاية بعدم قدرته | **NO (لا توجد فرصة No opportunity):** لم تتح للطفل فرصة تجربة المهمة بسبب قيود | **R (رفض Refusal):** يرفض الطفل المحاولة ولا يستطيع الوالد الإبلاغ.

• **تفسير نتيجة البند الواحد بالنسبة لخط العمر (Age Line):**

1. **متقدم (Advanced):** اجتياز بند يقع بالكامل على **يمين خط العمر** (يجتازه أقل من **25%** من الأطفال).
2. **طبيعي (OK):** اجتياز أو فشل أو رفض بند يقطعه خط العمر بين **المئين 25 و75 (25th–75th percentiles)**.
3. **تحذير/تنبيه (Caution):** فشل أو رفض بند يقطعه خط العمر **على أو بين المئين 75 و90 (75th–90th percentiles)**.
4. **تأخر (Delay):** فشل (أو رفض) في بند يقع بالكامل على **يسار خط العمر** (أي اجتازه أكثر من 90% من الأطفال الأصغر سنًا).

3. Overall Interpretation of Test & Recommendations for Referral

OVERALL INTERPRETATION OF TEST (3 OUTCOMES)

— **1) Normal: No delays** and a **maximum of one caution**.

— **2) Suspect: One or more delays** or **two or more cautions**.

— **3) Untestable: Refusals on one or more items completely to the left of the age line** or on **more than one item intersected by the age line in the 75th to 90th percentile area**.

RECOMMENDATIONS FOR REFERRAL (SUSPECT / UNTESTABLE)

— **Rescreen in 1 to 2 weeks** to rule out temporary factors.

— **If rescreen is suspect or untestable**, use **clinical judgment** based on:

1. Number of cautions and delays
2. Which items are cautions and delays
3. Rate of past development
4. Clinical examination and history
5. Availability of referral resources

التفسير الكلي للاختبار وتوصيات الإحالة (Referral Recommendations):

• **التفسير الكلي للاختبار:**

— **1. طبيعي (Normal):** لا يوجد أي تأخر (No delays) وبحد أقصى **تحذير واحد فقط (Maximum of one caution)**.

— **2. مشتبه به (Suspect):** وجود **تأخر واحد أو أكثر (≤ 1 delay)** أو **تحذيرين أو أكثر (≤ 2 cautions)**.

— **3. غير قابل للاختبار (Untestable):** وجود **رفض (Refusal)** لبند واحد أو أكثر يقع بالكامل **يسار خط العمر**، أو رفض **لأكثر من بند واحد في منطقة المئين 75–90**.

• **توصيات الإحالة للنتائج المشتبه بها أو غير القابلة للاختبار: إعادة الفحص بعد 1 إلى 2 أسبوع (Rescreen in 1 to 2 weeks)** لاستبعاد العوامل المؤقتة، وإذا ظلت النتيجة مشتبهًا بها أو غير قابلة للاختبار، يُستخدم الحكم السريري بناءً على: عدد ونوعية التحذيرات والتأخرات، ومعدل التطور السابق، والفحص السريري والتاريخ المرضي، وتوافر موارد الإحالة.

6. Students' Self-Evaluation Questions (Official Department MCQs)

1 **Assessment of growth and development is very important in early childhood because:**

- ○ **a. It helps identify potential learning disabilities, allowing for early intervention.** ✓
- ○ b. It provides a basis for predicting a child's future academic performance.
- ○ c. It only measures a child's physical growth, not cognitive or social development.
- ○ d. It is only useful for parents and not for healthcare providers.

الإجابة الرسمية: A — يساعد تقييم النمو والتطور في الطفولة المبكرة على الاكتشاف المبكر للمشاكل وصعوبات التعلم المحتملة مما يسمح بالتدخل المبكر (Early intervention).

2 **What is the primary purpose of using growth charts?**

- ○ a. To assess cognitive development
- ○ b. To evaluate social skills
- ○ **c. To track changes in height, weight, and head circumference over time ✓**
- ○ d. To measure intelligence quotient (IQ)

الإجابة الرسمية: C — الغرض الأساسي من استخدام منحنيات النمو (Growth charts) هو تتبع التغيرات في الطول والوزن ومحيط الرأس بمرور الوقت.

3 **Which professional the most likely to conduct a comprehensive developmental assessment?**

- ○ a. A financial advisor
- ○ **b. A pediatrician, psychologist specialist ✓**
- ○ c. A sports coach
- ○ d. A nutritionist only

الإجابة الرسمية: B — طبيب الأطفال أو الأخصائي النفسي (Pediatrician, psychologist specialist) هو المختص بإجراء التقييم التطوري الشامل.

4 **What is the primary purpose of the Denver II Test?**

- ○ a. To assess cognitive abilities
- ○ **b. To screen for developmental delays in children ✓**
- ○ c. To evaluate academic performance
- ○ d. To diagnose mental health disorders

الإجابة الرسمية: B — الغرض الأساسي من اختبار دنفر الثاني (Denver II) هو الفحص المسحي لاكتشاف التأخر التطوري في الأطفال (Screen for developmental delays in children).

5 **At what age range is the Denver II Test typically administered?**

- ○ a. Birth to 1 year
- ○ **b. 1 to 6 years ✓**
- ○ c. 6 to 12 years
- ○ d. 12 to 18 years

الإجابة الرسمية في جدول الكتاب (ص 77): B (1 to 6 years) — (ملحوظة: ذُكر في جدول المحاضرة ص 16 وص 25 أن المدى الكامل للاختبار من الولادة حتى 6 سنوات Birth to 6 years، وفي الاختيارات الرسمية للكلية الاختيار الصحيح هو B لأنه الوحيد الذي يمتد حتى 6 سنوات).

Official Answer Key Table (Page 40 / Booklet Page 77)

QUESTION NUMBER	CORRECT ANSWER	KEY CONCEPT TESTED
1	A	Early identification of potential learning/developmental problems for early intervention.
2	C	Growth charts track serial changes in height, weight, and head circumference over time.
3	B	Pediatrician / psychologist specialist conducts comprehensive developmental assessment.
4	B	Denver II screens for developmental delays in children.
5	B	Age range of Denver II administration (up to 6 years).

مفتاح الإجابات الرسمي للكلية:
1: B | 2: C | 3: B | 4: B | 5: B.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ ان لا إِلَه إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فارددهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين